

28 - 01- RÉANIMATION DU NOUVEAU-NÉ EN SALLE DE NAISSANCE - Pr. MAOULANINE

Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va voir un cours sur la réanimation du nouveau-né en salle de naissance. Quels sont les objectifs de ce cours ? Pour reconnaître ce qu'on t'a regardé, il faut décrire les principales étapes de la réanimation du nouveau-né à la salle de naissance.

Au moins de prédiction, la plupart du nouveau-né sont vigoureux et s'adaptent bien à la naissance. Environ 10 % du nouveau-né auront besoin d'une assistance à la naissance. Et 1 % du nouveau-né auront besoin d'une manœuvre de réanimation importante pour survivre, c'est-à-dire incubation, massage cardiaque et parfois utilisation des médicaments.

La réanimation du nouveau-né à la salle de naissance est une lutte douce, chaude, calme et propre de deux personnes entraînées contre l'hypoxie. Pour connaître les principales étapes physiologiques de l'adaptation de la vie extra-utérine, après le passage de la vie maternelle dépendante intra-utérine à l'autonomie aérienne, il y aura une instauration d'une respiration efficace, avec modification du système circulatoire, une autonomisation de la thermorégulation et un remplacement de la nutrition parentérale transplantatoire par l'alimentation législative. Ce sont des étapes qui vont être préparées.

Le processus de naissance, c'est sortir d'un milieu aquatique vers un milieu qui est aérien. Donc les poumons doivent être préparés, le système circulatoire doit être bien préparé pour permettre aux organes de bien être perfusés sans problème d'oxygénation. Les phénomènes respiratoires qui commencent en intra-utérine pour préparer les poumons, ça commence à partir, bien sûr, de 12 000 à 15 000 parfois si auparavant, avec l'apparition des mouvements respiratoires, entre 17 et 24 semaines, il y a une structure qui est canalaire et il devient alvéolaire à partir de 24 semaines.

Donc pour la viabilité d'un nouveau-né, maintenant on parle au-delà de 24 semaines dans notre contexte marocain, mais pour d'autres pays, ils parlent de 22 semaines. Ça veut dire que si on veut réanimer un nouveau-né, c'est à partir de 22 semaines d'améliorer. Les voies aériennes remplies de liquide pulmonaire, donc il faut les préparer, il va y avoir un liquide pulmonaire, et ce n'est pas un liquide amniotique.

Les résistances vasculaires et pulmonaires sont élevées, donc on voit que l'artère pulmonaire ne participe pas à la circulation intra-utérine. La sécrétion du surfactant commence dès 20 semaines jusqu'à 22 semaines. Parfois, on aura besoin d'administrer le surfactant chez certains nouveau-nés à 24, 26, 28 semaines, en fonction des indications.

Le surfactant, c'est une substance qui est sécrétée par l'hépnomocyte, qui va permettre aux alvéoles de rester ouvertes. La transition respiratoire et cardio-circulatoire normale à la licence. Après la licence, il va y avoir une constriction des artères et de la vigne ombilicale, entraînant une

augmentation de la pression sanguine systémique, une absorption du liquide pulmonaire, une relaxation des viscosités sanguines pulmonaires, avec une perfusion du lit vasculaire pulmonaire par la totalité du débit cardiaque, Production et sécrétion du surfactant, on a dit qu'à partir de 20-22 semaines, mais il y a quand même une structure qui augmente au fur et à mesure, après, donc, au-delà de 24 semaines.

Fermeture du canal artériel et instauration d'une respiration. On va voir dans cette diapo la circulation placentaire. On voit que le fœtus est perfusé par la veine ombilicale, qui vient donc à partir du placenta, et puis elle va se diversifier dans le cœlon du fœtus d'Arterius, et puis elle va passer dans la veine cave inférieure, et puis dans l'oreillette droite, et puis le sang va passer dans le ventricule droit et l'oreillette gauche.

Le ventricule gauche, il va passer dans l'aorte, et il va perfuser différents organes. Pour vous dire que les poumons sont exclus de la respiration fœtale. Ils sont en vasoconstriction, de la dépression, qui sont très augmentées.

Une fois qu'on a coupé le cordon, et le nouveau-né commence à respirer, il y a une inversion de dépression. On va voir qu'il y a une vasodilatation des vaisseaux pulmonaires, et il y a l'air qui passe dans les poumons, et il y a le sang qui va passer, oxygéné à travers les veines pulmonaires, à l'oreillette gauche. Donc la pression ici va être augmentée, il va y avoir une fermeture de foramen ovale, le sang va passer dans l'aorte, ventricule gauche, l'aorte, et puis il va perfuser différents organes.

Après clamping du cordon, donc juste on va répéter ce qu'on a dit, il y a une augmentation de la résistance vasculaire systémique, il y a une diminution des pressions dans le cœur droit, ça va permettre la fermeture du foramen ovale, et la fermeture du canal. Pour les phénomènes de thermorégulation, il faut craindre la déperdition thermique, le refroidissement qui est délétère sur la santé du nouveau-né, donc il y a des phénomènes de convection, les surfaces qui sont froides, il y a un phénomène de convection, l'air qui est froid, c'est pour ça que la température de la salle d'hôte à 25 degrés, la température de la table chauffante à 37 degrés, il faut faire attention à l'évaporation, la peau du nouveau-né prématurée, il est fin, donc il y a un risque d'hypothermie, la radiation, il change de la chaleur avec les objets d'environ, parfois les linges qui sont froids, il y a un risque d'hypothermie, donc il faut préchauffer les linges. Il y a un risque d'hypoglycémie, parce qu'on va couper le cordon, mais il y a des phénomènes qui vont aider, la mobilisation des réserves d'oblique aux gènes hépatiques, augmentation de sécrétion de l'oblique à gants, avec diminution de l'insuline.

Il y a d'autres phénomènes d'adaptation rénale et d'hygiène. Quelles sont les étapes de la réanimation neonatale ? D'abord, les étapes de la réanimation neonatale. Première étape, il faut anticiper les besoins de la réanimation.

On va voir dans une plaque qui va venir les différentes situations et quels sont les risques. Il faut

préparer le matériel nécessaire. Il faut évaluer le nouveau-né à chaque fois, à la première minute, à la troisième minute, à la cinquième minute, à la dixième minute, d'accord ? Donc c'est vrai que le score qu'on va voir, il permet juste l'évaluation à la première, à la cinquième, à la dixième minute, mais parfois on peut évaluer au-delà de la dixième minute.

Quels sont les gestes que nous devons faire en premier ? Quand est-ce qu'on doit ventiler par le masque ? Il faut préparer le matériel nécessaire pour la ventilation au masque. Quand est-ce qu'il faut intuber ? Donc on va voir certaines situations. Comment intuber ? Quand est-ce qu'on va administrer l'adrénaline ? Quand est-ce qu'on va l'utiliser au moins de 1% des licences ? Mais ce qui est important, c'est la prise en charge des parents du nouveau-né.

Il faut expliquer l'état du nouveau-né. Qu'est-ce qu'on va réaliser ? Parfois même avant la licence, il y a des risques, il faut leur expliquer les différentes étapes d'une manière vraie. Anticiper, le mot-clé de la réanimation néonatale.

Ça veut dire le matériel nécessaire, le personnel qui est qualifié. Comment on va transférer un nouveau-né de la salle d'accouchement à une salle de réanimation néonatale ? Parfois, il faut connaître, anticiper, connaître l'état de la maman, les facteurs de risque. S'il y a un risque infectieux, s'il y a un risque d'hémorragie, s'il y a un risque d'une asphyxie périnatale.

Pour cela, il faut une bonne communication entre les sages-femmes, l'obstétricien et le bébé. Anticiper, ça veut dire bien communiquer. Une information détaillée sur les risques néonataux, ceci avant la licence.

Anticiper les problèmes potentiels. Il faut planifier et préparer d'une manière réfléchie le matériel et le personnel. Il faut une direction claire et calme de la réanimation par un professionnel compétent en réanimation néonatale.

Anticiper les besoins de la réanimation. Est-ce qu'il y a des facteurs ? Donc, antipart. Si vous avez une maman qui est diabétique, le nouveau-né va y avoir un risque d'hypoglycémie.

Si vous avez un ennemi chez le fœtus, il faut faire attention, nous devons le transférer juste après la licence, nous devons faire le bilan nécessaire, chercher la cause de cette iso-immunisation. Si vous avez une maman qui est cardiaque, ou bien qui a une pathologie thérapeutique, il faut savoir les risques après. Si vous avez un oligo-amnios, il faut chercher les malformations rénales.

Si vous avez, au contraire, un poly-amnios, il faut chercher les malformations digestives. Donc ça, c'est très important. Si vous avez une rupture prématurée membrane, il y a un risque infectieux important.

Il faut donc faire le bilan nécessaire. Si le nouveau-né s'adapte bien ou s'adapte pas correctement, il faut faire le bilan nécessaire. Donc, vous voyez les différentes situations.

Est-ce que c'est une maman qui a un chorion amniotique ? Ça veut dire qu'il y a un risque infectieux, donc le chorion amniotique, ça veut dire qu'il y a infection du chorion, et il y a donc le liquide amniotique, donc le fœtus risque d'inhalier les gerbes et présenter un sepsis juste après la naissance. Est-ce qu'il y a une rupture des membranes qui est supérieure à 12 heures, c'est pas 18 heures ? Est-ce qu'il y a donc une macrosomie chez le fœtus avec un risque d'hypoglycémie en post-natal ? Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs facteurs intrapartus que nous devons connaître pour bien gérer la réanimation après la naissance. Est-ce qu'il y a un liquide qui est myconial ? Le myconium, c'est le premier sel du nouveau-né après la naissance.

Parfois, s'il y a une mauvaise perfusion, il peut relâcher son sphinctre. Il y a le liquide myconial qui va se diversifier. Donc, le liquide amniotique, ça devient un liquide myconial.

Il y a un risque d'une détresse respiratoire après la naissance. Il faut préparer le matériel et il faut vérifier le matériel. Donc, il faut laver les mains.

Là, c'est assez rigoureux. Il faut porter des charlottes, masque, surbus. La température de la salle doit être à 25 degrés.

Il faut vérifier la température de la table chauffante à 35 degrés. Les linges doivent être préchauffés. On a expliqué les phénomènes de déperdition endermique dans une diapo auparavant.

Il faut régler le dispositif d'aspiration parce qu'on doit parfois aspirer le nouveau-né par le nez ou par la bouche. Donc, il doit être à moins 100 et à moins 150 centimètres d'âge. Le centre d'aspiration doit être préparé.

Charlier 6 pour les prématurés. 8 pour le nouveau-né à terme. 10 en cas d'inhalation myconiale.

Le laryngoscope, nous devons vérifier son fonctionnement. Est-ce que les piles sont bien fonctionnelles ? Est-ce que la manche est bien fonctionnelle ? Est-ce que l'alarme est bien fonctionnelle ? Est-ce que les lampes sont bien fonctionnelles ? Pour ne pas avoir de surprise après la licence. Les cendres d'intubation doivent être préparées.

Charlier 2.5, 3 et 3.5. Le contrôle thermique, vous voyez, c'est un nouveau-né. Il y a un nouveau-né prématuré qu'on a mis dans un sac. On met une cendre en contact avec la peau pour vérifier la température.

36.5 jusqu'à 37.5. Le matin est bien préparé pour recevoir un nouveau-né. On va parler du clompage du cordon ombilical. Il n'y a pas d'indication chez le nouveau-né qu'il n'y a pas un risque d'hypoglycémie.

On parle du clompage tardif. Plus souvent, c'est un clompage qui est rapide. Un clompage tardif, il est indiqué chez le nouveau-né ayant un risque d'hypoglycémie, extraction par ventouse ou

accouchement par siège ou bien un risque hémorragique.

Un nouveau-né grand prématuré, une transfusion du placenta du nouveau-né, peut être obtenue en plaçant l'enfant environ 20 à 30 cm au-dessous de l'introduit vaginale et en clompant le cordon 60 secondes après la licence. C'est une notion très importante et j'insiste sur cette notion. Le score TAPGAR est basé sur cinq paramètres.

La fréquence cardiaque. S'il est absent, il est coté A0. S'il y a moins de sang, il est coté A1.

S'il y a plus de sang, il est A2. Les mouvements respiratoires. S'il est absent, il est A0.

S'il sent l'eau, il est A1. S'il y a un cri vigoureux, il est supérieur A2. Le tonus.

S'il est hypotonique, d'une manière générale, il est A0. S'il est faible, il est A1. S'il est en cas de réflexion, il est A2.

La coloration. S'il est pâle ou bleu, le nouveau-né va être A0. S'il y a des extrémités, il est A1.

S'il est rose, il est A2. La réactivation à la simulation nulle. Donc, il est A0.

S'il a des grimes, A1. S'il est vive, avec un cri, avec une toux, il est A10. Donc, vous voyez qu'un score TAPGAR supérieur à ça, c'est normal.

Inférieur à 3, c'est un état de mort apparente qui nécessite des mesures d'animation. Un score TAPGAR inférieur à 5, qui persiste à la cinquième minute, c'est un signe d'asphyxie prénatale. Ou bien, dont c'est paléopathie, un oxygène.

On va voir un nouveau-né à droite de l'écran, qui est normal, avec un TAPGAR à dix-dixième. Il est en cas de réflexion. Il est rose, il crie, avec des mouvements respiratoires qui sont corrects.

Il n'y a pas de cyanose d'extrémité. La réaction à l'incendie, il est avec un cri qui est vigoureux. C'est un nouveau-né au milieu, qui a un problème de respiration.

On voit qu'il a une dépression thoracique ici, un tirage surcostal. Avec une légère hypotonie, ce n'est pas comme celui-là, donc il est A8. Ce nouveau-né a des problèmes de la coloration.

Il a un problème de respiration, la fréquence cardiaque, qui est inférieure à 100. L'otonus, qui est en hypotonie, c'est un score TAPGAR qui est A4. Les premiers gestes sont très importants.

D'abord, il faut libérer les voisins. Il faut sécher, s'humilier, d'une manière correcte. Il faut ventiler, s'il y a une indication.

La libération des voisins, il faut produire correctement le nouveau-né. Il faut aspirer la bouche d'abord, le nez et parfois la trachée. Mais nous devons aspirer toujours le nouveau-né avec une bouche qui est ouverte.

J'aspire le nouveau-né par le nez, mais parfois je mets le doigt dans la bouche pour permettre la grande quantité de l'air qui passe dans l'oropharynx. Comme ça, on ne va pas avoir un risque d'asphyxie. Parfois, s'il y a une indication, on fait l'intubation.

Donc, premier geste, c'est A, airway. Ça veut dire libérer les voisins et ventilation. Breathing, provoquer un moment respiratoire.

Une simulation tactile, soit sur le panneau, soit on va flexibler le dos ou bien l'orthoaxe. Parfois, on peut utiliser le nouveau-né pour ces échecs de mouvements respiratoires. Parfois, on peut mettre les valeurs d'une saturation préductale, les valeurs normales.

Après 2 minutes, c'est 60. A 3 minutes, c'est 70. A 4 minutes, 80.

A 5 minutes, 85. A 10 minutes, 90. Circulation.

A, B, C, airway, breathing, circulation. Assurer un minimum de circulation suffisant. Ça veut dire qu'on va voir la perfusion périphérique, la coloration.

Et, bien sûr, on va ausculter pour dire qu'il y a une activité cardiaque, une perfusion qui est correcte. Les médicaments, ils ne sont pas indiqués que de moins de 1%. Donc, la réanimation, une question qui est très importante.

Si vous avez une bradycardie chez un nouveau-né, il faut voir un problème respiratoire au début. Il faut bien ventiler. On va ventiler pour voir l'algorithme qu'il faut chercher un problème respiratoire.

Ce n'est pas un problème cardiaque en premier. Parfois, on ventile correctement, il y a l'activité cardiaque qui va venir et là, il ne va pas. Sinon, on va faire un massage cardiaque.

C'est la circulation des débriefings. Il faut faire le briefing avant. Qui fait quoi, comment fait quoi.

Donc, on a dit entre 2 personnes, entre aînés. Parfois, on aura besoin de 3 personnes. Ça dépend du nombre du nouveau-né à réanimer.

Ça dépend des circonstances, etc. Le debriefing, c'est très important. C'est l'évaluation après chaque état.

Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on a bien fait, etc. Donc, il faut être positif, il faut être constructif, il faut une aide personnalisée. Voilà la position correcte.

Donc, en vert, il faut qu'il y ait un alignement entre le oropharynx et la trachée pour permettre de l'air de rentrer par la bouche et par le nez. Ici, il est en hyper-extension. Ici, en hyperflexion, vous voyez.

Donc, il va y avoir un redoutissement sur la circulation de l'air. On parle ici d'un nouveau-né qui

pèse 1 kg, 1,2 kg, 2 kg, 3 kg. Donc, tout mouvement incorrect peut retentir sur la respiration du nouveau-né.

Ici, on stimule. C'est une stimulation tactile. Vous voyez la bouche qui est ouverte.

Le nouveau-né est en bantounis. C'est une fille. Elle est rose.

Donc, on commence toujours l'aspiration par la bouche. Et ensuite, par le nez. Parfois, c'est le matériel pour la ventilation.

Il y a le nouveau-né. Il y a le masque. Il doit s'adapter.

Mais parfois, il y a ce qu'on appelle le neopuf. Ça permet d'intégrer une ventilation dans la table chauffante pour faire une ventilation à pression expiratoire positive. Le ballon doit être de 250 à 750 millilitres.

Les indications, c'est de ventiler un nouveau-né s'il a une apnée, s'il gaspe, si vous avez une fréquence cardiaque inférieure à 100. On a dit ça. Si vous avez une cyanose qui persiste malgré une effusion à 40 %, on dit qu'on commence la réanimation à 21 %, donc maximum 40 %. Et parfois, si on ajoute de l'oxygène à 40 % et il y a la cyanose, parfois, on doit ventiler au masque.

La fréquence de la ventilation doit être entre 40 à 60. C'est la fréquence normale respiratoire d'un nouveau-né. Il faut que le thorax se lève.

Il faut que les lèvres doivent être roses. Il faut que le cœur accélère si on parle d'une efficacité de la ventilation par ballon. Si, bien sûr, échec, on voit un... L'intubation, elle est indiquée s'il y a une ventilation inefficace par ballon au-delà de 15 minutes.

Si un nouveau-né, il a une araignée de la coproliia phragmatique, elle doit être intubée à la salle de naissance. C'est une contre-indication de la ventilation au masque. Si on a un nouveau-né qui a inhalé le liquide amniotique, le miconial, le miconium, c'est le premier sel du nouveau-né.

Parfois, s'il y a un problème de la perfusion en intra-hétérogène, le miconium va se diversifier dans la cavité hétérogène, dans le liquide amniotique, et le nouveau-né, avant sa naissance, il va y avoir de l'inspirant. Donc, il va inhaler le liquide miconial et il faut l'aspérer. Si le nouveau-né, il a crié, après la naissance, on va juste l'aspérer.

S'il n'a pas crié après la naissance, c'est une indication intubée, aspirée, et après, donc, on va ventiler par le masque. Toute détresse respiratoire grave chez un nouveau-né, c'est-à-dire tous les nouveaux-nés préstigmatiques en moins de 28 semaines, au moins de 1 kg, donc, parfois, on l'intube et il y a des indications de mettre le surfactant, là, c'est plus détaillé. Le matériel nécessaire, l'aryngoscope, une lame droite, la pince de magie, la pince de magie, les centres d'intubation sont ballonnés et on met, donc, un repère à la narine, tout ça, donc, c'est plus détaillé, mais vous devez le prendre quand même.

Après l'intubation, il faut vérifier la position de la canule d'intubation, il faut ausculter, il faut fixer, il faut placer une sonde gastrique, la sonde gastrique en place, et il faut, bien sûr, brancher le nouveau-né avec un respirateur. Tout ça, c'est plus détaillé, donc, juste, ce sont des informations. Pour le massage cardiaque externe, il est rarement indiqué chez un nouveau-né, ainsi que l'expansion volumique et l'adrénaline, mais quand même, on va vous parler de ça d'une manière... Le massage cardiaque, donc, la fréquence normale, c'est peut-être obtenu 90 à 120, avec une dépression de 1,5 à 12 cm, il faut faire attention parce qu'il risque de casser les côtes, donc, une ventilation avec trois dépressions, on a dit entre 40 à 60, si on fait 3 x 40, c'est 120, donc, vous voyez que 3 fois, on va faire des dépressions, plus une ventilation, et donc, on va respecter la fréquence cardiaque qui est à 60, 40 à 60, et la fréquence qui est au-delà de 60.

L'adrénaline, rarement indiqué, la dose est 001 à 003 mg/kg, on répète toutes les 3 à 5 minutes. Bien sûr, ça, c'est plus... Ce qui est important après la réanimation, c'est faire le dépistage des malformations. Il y a 4 malformations à dépister.

Il y a l'atrésie de l'œsophage, l'atrésie du cœur, l'hernie de la coprolithaphatie, parfois, on peut la diagnostiquer en antenatal, même avant la naissance, mais parfois, si la maman n'est pas suivie, il faut faire le dépistage à la salle de naissance, et les malformations, l'absence de perméabilité anale. Donc, il faut prendre en considération, ça veut dire le poids, la taille, et le PC, le périmètre crânien. Il faut administrer la vitamine K. Il faut faire les soins du corps dans... Bien sûr, après la stabilité du nouveau-né.

Il faut faire un contrôle de la glycémie chez un nouveau-né qui a un risque d'hypoglycémie. On a dit le nouveau-né qui a un risque d'hypoglycémie, c'est le nouveau-né qui est macrosome, qui a plus de 4,5 kg, un nouveau-né de mère diabétique, et un nouveau-né qui est prématuré. Généralement, on fait le contrôle de la glycémie, parce qu'ils ont un risque d'hypoglycémie.

Bien sûr, un nouveau-né qui est en détresse respiratoire, il a un risque d'hypoglycémie, et ça, il faut le noter. La prise en charge des parents durant l'accouchement est très importante, parce qu'on a dit qu'il faut anticiper les problèmes. S'il y a un risque de malformations, risque infectieux, risque de prématurité, il faut toujours discuter avec les parents avant la naissance.

Donc, bien sûr, s'il vient à temps, il faut conseiller de discuter avant la naissance. La prise en charge de leur bébé, ainsi que les problèmes peuvent en survenir. La discussion doit être d'une manière simple, avec un langage qui est clair.

La présence des parents au moment de la réanimation, parfois on peut accepter ça, mais parfois on ne peut pas accepter, donc ça peut être un cas. La tâche importante et exigeante, si un nouveau-né présente une adaptation pathologique ou d'une malformation, ça, il faut discuter d'une manière claire, avec un langage et certaines questions qu'on peut reporter. Donc, les réponses, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions, mais il faut savoir répondre à certaines questions en matière de pronostic et de prise en charge.

Donc, après avoir passé l'étape, l'important, c'est de mettre le nouveau-né en sécurité. Les missions de réanimation entravent les contacts et les interactions entre la mère et son enfant. Donc, il faut toujours informer la maman sur le devenir de son bébé.

Parfois, donc, on va le réanimer, il va être transféré dans un service, on va dire à la maman, voilà, le nouveau-né présente un problème, comme ça, la maman doit être au courant de ce qui va être réalisé chez son nouveau-né. Donc, même si on est dans des situations difficiles, ceux-ci doivent toujours être favorisés. Il est préférable de réanimer un nouveau-né dans une pièce séparée en l'absence des parents.

Il est important que l'équipe qui s'occupe du nouveau-né informe régulièrement les parents de l'état de leur enfant et de sa prise en charge. Face à l'algorithme, donc, on a dit qu'il faut prévenir l'hypothermie, la température de la salle doit être à 25 degrés, la température de la table chauffante à 37. Il faut évaluer, donc, la respiration et la fréquence cardiaque, bien sûr, le score d'Apgar et la coloration.

Si on a des apnées avec une fréquence qui est inférieure à 100, il faut libérer les voisins aériens et voir, donc, vous voyez que dans 30 secondes, s'il a besoin d'être ventilé par le masque, c'est un 25 %, et puis au maximum 40 %. Il faut réévaluer, voir s'il y a une bonne réévaluation, respiration spontanée, oui, donc, saturation qui est correcte, en fonction, donc, de 10 minutes, de 3 minutes à 5 minutes à 10 minutes. Et puis, donc, si malheureusement la fréquence cardiaque est inférieure à 60, ça, c'est une indication à une ventilation effluodoquante à 100 %, et parfois même l'intubation et un massage cardiaque qui est indiqué. Donc, vous voyez que nous partons par le principe qu'il faut faire des gestes simples à la salomissance, aspiration, stimulation tactile, évaluation régulière de la fréquence cardiaque et de la saturation, et chaque situation va nous permettre, avec l'algorithme, de faire les gestes nécessaires à chaque situation.

Il n'y a pas de place à l'improvisation. Il faut anticiper, il faut préparer nos matériels, l'équipe, il faut informer les parents, il faut essayer d'anticiper et de respecter les procédures. Il faut une équipe qui est bien entraînée, avec un seul dirigeant.

Il faut communiquer entre les membres de la famille, avec les parents. Il faut débriefer les actions qu'on a réalisées et à chaque fois faire le nécessaire de communiquer et de revoir si on a fait une bonne réanimation.